

1. Introducción y relevancia en Salud Pública y en el EUNACOM

La salud de una persona y de las comunidades **no depende exclusivamente del acceso a servicios de salud o de la biología individual**, sino de un conjunto complejo de **condiciones sociales, económicas, culturales y ambientales** que influyen sobre ella: los llamados **Determinantes Sociales de la Salud (DSS)**.

En Chile, la comprensión y abordaje de estos determinantes es esencial para implementar políticas de equidad y justicia sanitaria. De hecho, los DSS explican en gran medida **las brechas de salud entre distintos grupos socioeconómicos, territorios o géneros**.

En el **EUNACOM**, el tema se evalúa porque permite al futuro médico general **comprender el contexto social de la enfermedad**, orientar su práctica en Atención Primaria de Salud (APS) con enfoque de equidad y aplicar acciones integrales en prevención, promoción y atención comunitaria.

2. Conceptos fundamentales y marco conceptual

2.1. Definición

“Los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, y los sistemas que influyen sobre esas condiciones.”
(OMS, Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud, 2008)

Estas condiciones están moldeadas por la **distribución del poder, los recursos y las oportunidades**, tanto a nivel nacional como local, lo que genera desigualdades en los resultados de salud.

2.2. Enfoque conceptual de la OMS / OPS

La OMS distingue dos grandes categorías:

1. **Determinantes estructurales:** condiciones macroeconómicas, políticas y culturales que generan desigualdades (por ejemplo, ingreso, educación, género, etnia).
2. **Determinantes intermedios:** condiciones materiales y psicosociales que median el efecto de los estructurales (por ejemplo, vivienda, trabajo, alimentación, apoyo

social, servicios de salud).

Ambos niveles interactúan continuamente y determinan la **posición social de los individuos** y su exposición diferencial a riesgos y oportunidades de salud.

2.3. Modelo conceptual adaptado a Chile

El **MINSAL (2017)**, siguiendo la OMS, propone un marco con tres niveles:

Nivel	Tipo de determinante	Ejemplos
Estructura I	Factores políticos, económicos y culturales	Política fiscal, sistema educativo, modelo económico, inequidad de género
Intermedio	Condiciones de vida y trabajo	Vivienda, empleo, acceso a servicios básicos, ambiente
Individual	Factores conductuales y biológicos	Estilo de vida, hábitos, predisposición genética

Este modelo permite diseñar intervenciones que aborden tanto las causas **“aguas arriba” (estructurales)** como **“aguas abajo” (conductuales)**.

3. Determinantes estructurales de la salud

3.1. Educación

Uno de los predictores más potentes de la salud.

- A mayor nivel educativo, menor mortalidad y morbilidad.
- La educación influye en el acceso a empleo, ingresos y en la capacidad de adoptar hábitos saludables.

3.2. Ingreso y empleo

- La pobreza y el desempleo crónico se asocian con mayor riesgo de enfermedades crónicas, estrés, violencia y desnutrición.
- En Chile, la **Encuesta CASEN 2022** mostró que las comunas con mayor pobreza multidimensional presentan **tasas más altas de mortalidad infantil y obesidad**.

3.3. Género y desigualdad

- Las mujeres enfrentan mayores cargas de trabajo no remunerado y barreras de acceso a salud sexual y reproductiva.
- Los hombres presentan mayor mortalidad por causas externas (accidentes, violencia).

3.4. Grupo étnico y pertenencia cultural

- La población mapuche, aimara y migrante evidencia desigualdades en atención sanitaria y en determinantes sociales como educación y vivienda.
- La **Política de Salud y Pueblos Indígenas (MINSAL 2018)** busca revertir esta inequidad.

3.5. Gobernanza y políticas públicas

- Las decisiones macroeconómicas y de planificación urbana impactan directamente la salud (por ejemplo, políticas de vivienda o transporte).
- Los municipios con gestión activa de promoción muestran mejores indicadores locales.

4. Determinantes intermedios de la salud

4.1. Vivienda y entorno físico

- El hacinamiento, la falta de ventilación o calefacción inadecuada aumentan infecciones respiratorias y estrés térmico.
- Las viviendas en zonas contaminadas (industriales o mineras) se asocian a mayor riesgo de enfermedades respiratorias y cáncer.

4.2. Condiciones laborales

- Jornadas extensas, trabajo informal o exposición a riesgos ocupacionales aumentan el ausentismo y las lesiones.
- Chile cuenta con la **Ley 16.744** que regula enfermedades y accidentes laborales.

4.3. Alimentación y seguridad alimentaria

- El acceso desigual a alimentos saludables genera **malnutrición por exceso**.
- Según la **ENS 2016–2017**, el 74 % de los adultos chilenos tiene sobrepeso u obesidad, con mayores cifras en los quintiles más pobres.

4.4. Redes de apoyo social

- La soledad y el aislamiento aumentan el riesgo de depresión y deterioro cognitivo.
- Las comunidades cohesionadas presentan mejores indicadores de salud mental y resiliencia.

4.5. Acceso a servicios de salud

- Las barreras geográficas, económicas y culturales limitan el uso de servicios preventivos.
- Ejemplo: menor cobertura de mamografía o PAP en zonas rurales o en mujeres migrantes.

5. Determinantes individuales y conductuales

Aunque las condiciones sociales determinan gran parte del estado de salud, los **comportamientos individuales** modulan ese efecto.

Entre los principales determinantes individuales se incluyen:

- Tabaquismo.
- Sedentarismo.
- Consumo de alcohol y drogas.

- Estrés crónico.
- Adherencia terapéutica.
- Conductas sexuales de riesgo.

Estos factores son el foco de programas de promoción como **Elige Vivir Sano, Vida Sana y Programa Cardiovascular (PSCV)**.

6. Situación epidemiológica en Chile

6.1. Desigualdades en salud

- La **brecha de esperanza de vida** entre comunas de alto y bajo ingreso supera los **10 años**.
- La **mortalidad infantil** es mayor en comunas rurales o de bajos ingresos.
- Las **ECNT (HTA, DM2, obesidad)** afectan con más fuerza a los sectores vulnerables.
- La **salud mental** presenta mayor deterioro en mujeres y trabajadores precarizados.

6.2. Transición epidemiológica y social

Chile atraviesa una etapa de **envejecimiento acelerado**, coexistencia de enfermedades crónicas y nuevos desafíos como la migración y el cambio climático.

Estas transformaciones exigen una **visión integral de los determinantes sociales**, incorporando factores ambientales y globales.

7. Intervención sobre los determinantes sociales

El abordaje de los DSS se estructura en tres niveles complementarios:

Nivel

Estrategia

Ejemplo

Político-estratégico	Reducción de inequidades estructurales.	Políticas de redistribución de ingresos, educación gratuita, vivienda digna.
Intersectorial	Coordinación entre salud, educación, trabajo y municipio.	Programas “Comuna Saludable” o “Chile Crece Contigo”.
Comunitario e individual	Fortalecimiento del autocuidado y la participación.	Promotores de salud, talleres de vida saludable, clubes de adultos mayores.

8. Programas y políticas ministeriales vinculadas

8.1.

Política Nacional de Promoción de la Salud (2018)

Enfatiza la creación de entornos saludables, equidad y participación social.

8.2.

Estrategia Nacional de Salud 2021–2030

Incluye metas intersectoriales de reducción de obesidad, tabaquismo, y mejoramiento del bienestar mental.

8.3.

Chile Crece Contigo

Dirigido a la primera infancia, busca igualar oportunidades de desarrollo desde el nacimiento.

8.4.

Estrategia Municipios, Comunas y Comunidades Saludables

Integra municipios en la promoción de entornos seguros y saludables.

8.5.

Plan Nacional de Salud Mental 2021–2030

Aborda los determinantes psicosociales de los trastornos mentales, con enfoque comunitario.

9. Rol del médico general y la APS

El **médico general**, dentro del MAIS, es un actor clave para identificar y abordar los determinantes sociales en su territorio.

Función	Ejemplo práctico
Evaluar contexto familiar y social	Uso de ficha familiar, genograma y ecomapa.
Detectar riesgos sociales	Violencia, consumo, desempleo, aislamiento.
Intervenir y derivar	Coordinación con trabajador social, municipios y redes.
Educar y empoderar	Talleres comunitarios, educación sanitaria.
Participar en diagnósticos participativos	Elaboración del Plan Comunal de Salud.
Defender equidad sanitaria	Promover acceso igualitario a prestaciones.

10. Enfoques emergentes

10.1. Determinantes ambientales

Incluyen contaminación del aire, agua y suelo, cambio climático, deforestación y urbanización descontrolada.

Ejemplo: incremento de infecciones respiratorias en ciudades con alta contaminación (Santiago, Temuco).

10.2. Determinantes globales

Migración, conflictos, pandemias y comercio internacional impactan los determinantes locales.

Ejemplo: vulnerabilidad sanitaria de migrantes sin acceso regularizado a salud.

11. Errores comunes en EUNACOM y razonamientos errados

Error frecuente	Corrección
Pensar que los determinantes son solo conductuales	Incluyen factores estructurales, económicos y ambientales.
Creer que el médico solo debe tratar enfermedades	Debe también identificar y actuar sobre los determinantes sociales.
Confundir promoción con asistencia social	La promoción aborda determinantes para prevenir enfermedad, no solo mitigar pobreza.
Suponer que la equidad es sinónimo de igualdad	La equidad busca compensar diferencias según necesidades.
Desconocer la función intersectorial	Salud, educación y municipio deben coordinarse.

12. Normativa y referencias ministeriales

- OMS (2008). Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud.
 - OPS/OMS (2010). Renovación de la Atención Primaria de Salud.
 - MINSAL (2013). Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria.
 - MINSAL (2018). Política Nacional de Promoción de la Salud.
 - MINSAL (2021). Política Nacional de Salud 2021–2030.
 - Encuesta Nacional de Salud (ENS 2016–2017).
 - CASEN (2022). Informe de Desigualdad en Salud.
-

13. Resumen final — 5–7 ideas clave

1. Los **determinantes sociales de la salud** son las condiciones estructurales, intermedias e individuales que explican las diferencias en salud entre personas y comunidades.
2. El **modelo de la OMS (2008)** distingue factores estructurales (ingreso, educación, género), intermedios (vivienda, trabajo, redes) y conductuales.
3. En Chile, las **desigualdades sanitarias** se asocian a pobreza, ruralidad, etnia y brechas de acceso.
4. El **médico general en APS** debe identificar y actuar sobre los determinantes desde la perspectiva familiar y comunitaria.
5. Las **políticas ministeriales** (MAIS, Chile Crece Contigo, Estrategia de Promoción, Comuna Saludable) buscan reducir brechas sociales en salud.
6. La **intersectorialidad y participación comunitaria** son pilares para el abordaje sostenible de los DSS.
7. Comprender los determinantes sociales es clave en el **EUNACOM** porque conecta la medicina clínica con la salud poblacional y la justicia social.